



Infocop revisa la evidencia sobre el uso prolongado de antidepresivos, ASAENES publica una guía de derechos en salud mental y un estudio documenta el abuso de poder en la formación médica: claves del 4 de septiembre de 2026

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Infocop recoge una revisión que cuestiona la solidez de la evidencia sobre el uso prolongado de antidepresivos, al no distinguir siempre entre recaídas y síntomas de retirada. ASAENES Salud Mental Sevilla ha publicado una guía práctica para ayudar a las personas a conocer y defender sus derechos en el ámbito de la salud mental. Un estudio cualitativo de la Universidad Miguel Hernández y el CIBERESP documenta situaciones de abuso de poder relatadas por estudiantes y residentes de Medicina en España. Además, una investigación realizada en centros privados de la Comunidad de Madrid analiza cómo el apego del paciente y el estilo del terapeuta predicen la calidad de la alianza terapéutica, y un estudio en Nature Communications aporta nueva evidencia sobre el sistema glinfático y la eliminación de proteínas asociadas al Alzheimer durante el sueño.

Noticias nacionales

Una revisión cuestiona la solidez de la evidencia que respalda el uso prolongado de antidepresivos

Infocop, medio de comunicación del Consejo General de la Psicología de España, ha difundido un análisis publicado en la revista *Australian Journal of General Practice* por Horowitz, Wallis y Moncrieff (2026), que revisa la evidencia disponible sobre el mantenimiento de los tratamientos antidepresivos durante más de doce meses. Según recoge el artículo, la principal evidencia a favor de la continuidad del tratamiento procede de estudios en los que las personas son asignadas a continuar o suspender la medicación, pero estos trabajos no distinguirían adecuadamente entre los síntomas de retirada y las recaídas depresivas, lo que podría llevar a sobreestimar los beneficios de mantener el fármaco. El análisis revisa el ensayo ANTLE, uno de los estudios más citados en este debate, y señala que, aunque mostró menores tasas de recaída entre quienes continuaron la medicación, también informó de síntomas de retirada frecuentes y persistentes sin diferenciarlos claramente de una recaída. Los autores citan además un metaanálisis según el cual las personas que reducen los antidepresivos de forma gradual y con apoyo psicológico presentan tasas de recaída similares a las de quienes continúan con el tratamiento. Entre los riesgos asociados al uso prolongado, el artículo menciona la disfunción sexual, que según los estudios revisados puede afectar entre el 50 % y el 80 % de las personas usuarias, así como síntomas de retirada que, según los datos revisados, podrían prolongarse durante meses o años en hasta el 15 % de quienes han utilizado estos tratamientos durante periodos largos. Los autores concluyen que la continuidad del tratamiento debería revisarse periódicamente, favoreciendo la toma de decisiones compartida entre profesionales y pacientes.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Una guía práctica ayuda a reconocer y defender los derechos de las personas con problemas de salud mental

ASAENES Salud Mental Sevilla ha publicado la guía «No todo está en los Manuales: Derechos en Salud Mental», un documento recogido por Infocop que ofrece una herramienta práctica, accesible y comprensible para ayudar a las personas a conocer, identificar y defender sus derechos en el ámbito de la salud mental. La guía se organiza en torno a varios ejes: el derecho a la autonomía personal y a la toma de decisiones informadas sobre el propio tratamiento y proyecto vital; el derecho a un trato digno y a la no discriminación, señalando prácticas como dirigirse únicamente a la familia o identificar a la persona por su diagnóstico; el derecho a la intimidad y la vida privada, con ejemplos como el acceso a la habitación sin previo aviso durante un ingreso; el derecho a la información, subrayando que no puede existir un consentimiento válido sin una comprensión real de lo que se explica; el derecho a una vida plena, que incluye vivienda, empleo y relaciones sociales; y el derecho a la libertad y a no sufrir tratos degradantes, cuestionando prácticas como las sujeciones mecánicas o la sedación forzada. El documento concluye con un apartado de recursos y mecanismos de defensa, entre ellos el Defensor del Pueblo Andalúz, la Oficina de Atención a la Discapacidad y el CERMI, subrayando que la defensa de derechos no debe afrontarse en solitario.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España) / ASAENES Salud Mental Sevilla

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

Un estudio cualitativo documenta situaciones de abuso de poder durante la formación médica en España

Un estudio cualitativo publicado en la revista Gaceta Sanitaria por Sánchez-Miralles, Blanes-Mira y Hernández-Aguado (2026), investigadores de la Universidad Miguel Hernández y el CIBERESP, ha documentado situaciones de abuso de poder relatadas por estudiantes y residentes de Medicina en España, según recoge Infocop. Los autores entrevistaron a 10 estudiantes de Medicina y 15 médicos residentes de instituciones públicas, entre marzo y septiembre de 2024, en sesiones de entre 45 y 90 minutos. Los participantes describieron humillaciones públicas, insultos, comentarios sexistas y, en algunos casos, tocamientos y besos sin consentimiento. Prácticamente todos los entrevistados afirmaron haberse sentido invisibles o ignorados sistemáticamente durante sus rotaciones clínicas, y más de la mitad percibió

falta de interés por parte de algunos profesionales hacia su supervisión y enseñanza. Entre los residentes, se señaló una estructura fuertemente jerárquica en los servicios hospitalarios, supervisión insuficiente durante el primer año, sobrecarga laboral y arbitrariedades en el reparto de guardias y tareas formativas. El estudio recoge también testimonios de discriminación de género, comentarios racistas y acoso sexual. Pese a la gravedad de las situaciones descritas, solo 4 estudiantes y 6 residentes presentaron quejas formales, señalando como principales barreras el miedo a represalias, la falta de confidencialidad y la percepción de que denunciar no serviría para nada. Los autores concluyen que los resultados respaldan la idea de que el abuso forma parte del proceso de formación médica y reclaman planes institucionales de prevención y denuncia tanto en el ámbito académico como sanitario.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España) / Gaceta Sanitaria

Publicaciones científicas recientes

Báñez, N. B., Saúl, L. A., & Corbella, S. (2026). Predictors of therapeutic alliance: Patient attachment and the personal style of the therapist. *Clinical and Health*, 37, e260719.

<https://doi.org/10.5093/clh2026a5>

DOI: 10.5093/clh2026a5

Hallazgo: Un estudio con 264 pacientes y 28 terapeutas de cuatro centros privados de la Comunidad de Madrid analizó el papel predictivo del apego del paciente y del estilo personal del terapeuta sobre la alianza terapéutica, diferenciando entre una fase inicial (las cinco primeras sesiones) y una fase avanzada (a partir de la sexta sesión). El apego evitativo del paciente resultó uno de los predictores más consistentes de una alianza terapéutica más débil, tanto al inicio como en fases avanzadas del tratamiento. En la fase inicial, un mayor deterioro del funcionamiento psicológico general del paciente también se asoció con alianzas más débiles. En el conjunto de la muestra, la función atencional del terapeuta —su capacidad de mantenerse receptivo y ajustado a las necesidades cambiantes del paciente— fue el predictor que más contribuyó a explicar las diferencias en la calidad global de la alianza, mientras

que su función expresiva se relacionó específicamente con el vínculo emocional entre paciente y terapeuta.

Implicación clínica: Los autores sugieren que los pacientes con apego evitativo podrían beneficiarse de aproximaciones graduales y poco intrusivas en el plano emocional durante las primeras etapas del tratamiento, y subrayan la importancia de que los psicólogos sean conscientes de cómo su propio estilo personal influye en la construcción de la alianza terapéutica. Se trata de un estudio realizado en un contexto clínico privado concreto, por lo que sus conclusiones podrían no ser directamente extrapolables a otros dispositivos asistenciales.

Dagum, P., Elbert, D. L., Giovangrandi, L., Singh, T., Iliff, J. J. et al. (2026). The glymphatic system clears amyloid beta and tau from brain to plasma in humans. *Nature Communications*, 17, Article 715. <https://doi.org/10.1038/s41467-026-68374-8>

DOI: [10.1038/s41467-026-68374-8](https://doi.org/10.1038/s41467-026-68374-8)

Hallazgo: Un ensayo aleatorizado cruzado con 39 participantes ha encontrado que la eliminación glinfática durante el sueño normal incrementa los niveles plasmáticos matutinos de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, en comparación con la privación de sueño. Los cambios en la resistencia del parénquima cerebral, la frecuencia cardíaca y la potencia delta del electroencefalograma durante la noche predijeron los cambios observados en los niveles plasmáticos de las proteínas A β 42, np-tau181, np-tau217 y p-tau181. Estas predicciones replicaron los resultados de un modelo multicompartimental basado en datos publicados sobre la salida de las proteínas amiloide beta y tau desde el cerebro hacia el plasma.

Implicación clínica: Los autores concluyen que los procesos fisiológicos activos durante el sueño, en particular la reducción de la resistencia del parénquima cerebral, favorecen la eliminación glinfática nocturna de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer hacia el plasma. Los resultados sugieren que reforzar la función glinfática podría explorarse como una posible diana terapéutica para reducir el desarrollo y la progresión de la patología asociada al alzhéimer, si bien se trata de un ensayo con una muestra reducida cuyos hallazgos requerirán confirmación en estudios de mayor tamaño.

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Guías y materiales accesibles sobre derechos en salud mental:** Documentos divulgativos elaborados por asociaciones y entidades del ámbito de la salud mental para ayudar a las personas usuarias y a sus familias a conocer, identificar y ejercer sus derechos en el contexto clínico y social.
- **Recursos de apoyo a la toma de decisiones compartida en tratamientos farmacológicos:** Materiales de psicoeducación pensados para acompañar a profesionales y pacientes en la valoración conjunta de los beneficios y riesgos de mantener, reducir o suspender un tratamiento farmacológico, favoreciendo un proceso informado y seguro.

Prioridades del día

Revisar periódicamente los tratamientos antidepresivos de larga duración

A la luz de la evidencia revisada por Infocop, puede ser útil valorar junto con cada paciente la continuidad de los tratamientos antidepresivos mantenidos durante más de doce meses, explorando de forma conjunta los posibles beneficios y riesgos y favoreciendo la toma de decisiones compartida.

Incorporar la perspectiva de derechos en la práctica clínica diaria

A partir de la guía difundida por ASAENES Salud Mental Sevilla, puede ser oportuno revisar prácticas cotidianas de la consulta, como la forma de explicar los tratamientos o de dirigirse a la persona atendida, para favorecer su autonomía, su intimidad y su participación real en las decisiones que le afectan.

Adaptar el estilo terapéutico al perfil de apego de cada paciente

Según los resultados del estudio de Báñez, Saúl y Corbella, puede ser útil prestar especial atención a los pacientes con apego evitativo, explorando

aproximaciones graduales y poco intrusivas en las primeras sesiones para favorecer una alianza terapéutica más sólida.

